

12 - 04- LA MENACE D'ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ - Pr. BASSIR

(0:03 - 0:37)

Bonjour, aujourd'hui on va voir le cours La menace d'accouchement prématuré. Selon l'OMS, on appelle accouchement prématuré toute naissance survenant entre 22 et 37 semaines d'aménorrhée, soit avant 259 jours d'aménorrhée d'un enfant de plus de 500 grammes. La menace d'accouchement prématuré se caractérise par l'association de contractions utérines et des modifications cervicales.

(0:38 - 1:28)

On appelle menace d'accouchement prématuré tout accident survenant entre 22 et 37 semaines d'aménorrhée évoluant spontanément vers l'accouchement en absence de traitement. La menace d'accouchement prématuré quantitativement est la première cause d'hospitalisation pendant la grossesse en unité de grossesse à risque. Le problème de cette menace d'accouchement prématuré, c'est la prématurité, qui engendre un coût financier non négligeable de la prise en charge, à savoir qu'il y a un risque de mortalité périnatale de 37% et de mortalité néonatale précoce de 62%.

(1:28 - 2:01)

Plus l'âge gestationnel est faible, plus les complications sont plus graves. Les conséquences à craindre sont les séquelles neurologiques qui peuvent être importantes chez le nouveau-né, d'où l'intérêt d'une prévention et d'un traitement adéquat. L'incidence en France est passée de 8,2% en 1972 à 5,6% en 1990.

(2:03 - 2:42)

La fréquence entre 33 et 36 semaines est de 5%, entre 31 et 33 semaines est de 0,5%, et moins de 31 semaines est de 0,7%. Les facteurs de risque Les antécédents gynéco-obstétricaux L'antécédent d'un accouchement prématuré Une femme qui a déjà fait un accouchement prématuré a plus de risque de refaire ou bien de faire cette menace d'accouchement prématuré. L'intervalle entre deux grossesses Un délai de moins de 12 mois expose cette femme à une menace d'accouchement prématuré.

(2:43 - 7:54)

La menace d'avortement au cours du premier trimestre Les interruptions volontaires de grossesse Surtout si la femme a subi plus de trois interruptions volontaires de grossesse. La cause, c'est surtout les traumatismes au niveau du col à cause des dilatations, et donc le col devient plus veillant. Les fausses couches tardives Les antécédents de colonisation Pour les

facteurs socio-économiques, anthropométriques, démographiques et environnementaux L'origine ethnique, donc la femme noire est plus à risque Le poids, la faible prise de poids surtout si le poids de départ est déjà faible L'âge, le jeune âge, donc les moins de 18 ans sont plus exposés à cette menace d'accouchement prématuré La situation socio-économique, faible revenu, violence conjugale, statut de femme isolée Le stress et les facteurs psychosociaux Donc ce sont des résultats qui sont contradictoires Les drogues, l'exposition à l'alcool, le tabac, la cocaïne augmentent ce risque Pour les facteurs de risque liés à la grossesse en cours Une grossesse issue d'une fécondation in vitro Une insertion anormale du placenta Des grossesses multiples Des infections urogénitales Et il y a des causes qui sont directes à l'accouchement prématuré C'est l'abécence cervico-ésimique, c'est-à-dire le col est déjà dilaté L'hydramnios Et l'utérus mal formé Pour l'ithiopathogénie, en principe, c'est la somme de facteurs mécaniques et infectieux La surdistension utérine, donc en cas d'hydramnios ou de grossesse gémellaire Entraîne une production de prostaglandine Cette production peut également être augmentée à la suite d'une infection ou bien d'une inflammation Ce qui entraîne un émacissement des membranes Puis des contractions utérines Et des modifications cervicales avec une hémorragie, voire une rupture prématurée des membranes Donc, on peut avoir une menace d'accouchement prématuré suite à des anomalies cervico-utérines À savoir des malformations utérines, des myomes ou bien ovulaires Ou bien il y a des facteurs locaux qui entraînent surtout les prostaglandines Qui, dans la sécrétion, est une réponse locale à une infection ou une inflammation amniocoréale Ce qui entraîne des contractions utérines associées à des modifications cervicales Cette réaction inflammatoire amniocoréale est due au passage par voie ascendante de germes Essus du tractus génital au passage transplacentaire Ces prostaglandines seraient synthétisées sous l'effet de la production maternelle de cytokines Et de l'infiltration locale par des polynucléaires activés Ce qui entraîne une maturation cervicale, des contractions utérines responsables de la menace d'accouchement prématuré Les étiologies Il y a les causes infectieuses Toute infection maternelle systémique Une infection urinaire haute ou basse Une infection cervico-vaginale Une infection buccodentaire, gingivite Ou bien une infection iatrogène Les causes utérines L'abécence cervico-ismique Le diagnostic est posé pour l'abécence cervico-ismique Devant des antécédents de désaffortement tardif ou bien d'accouchement prématuré Avant 32 semaines d'améliorée Le diagnostic est posé lors de la consultation Par le test à la bougie de égard Numéro 8 La bougie qui est introduite facilement Lors de la consultation Ou bien par une hystérosalpingographie Le traitement est un traitement prophylactique Par cerclage Qui se fait entre 15 et 16 semaines d'améliorée Qui reste en place pendant toute la durée de la grossesse Jusqu'à 35 semaines d'améliorée A ce moment-là, on peut enlever le cerclage Les malformations utérines Qui peuvent être congénitales Cloison, utérus, bicorné, etc.

(7:55 - 24:08)

Ou bien acquises, signifient des fibromes Et l'exposition au destilbat Les causes ovulaires Les grossesses multiples Le plan intact Nous avons le plan intestinal On va nécessairement Nécessairement La brèche On peut aussi Les peuples Les peuples On peut aussi On peut aussi

Premier traitement prématuré et donc on parle de cause iatrogène. Pour le diagnostic, le diagnostic positif pour parler d'accouchement prématuré ou bien de menace d'accouchement prématuré, ça suppose que cette patiente a une datation qui est précise, soit qu'il a une date de dernière règle qui est précise, soit il se rappelle du rapport fécondant, soit qu'il a une échographie précoce, donc de datation surtout entre 11 et 13 semaines d'aménorrhée. Les cimes fonctionnelles, les contractions utérines sont douloureuses, régulières, perceptibles au moins une à deux toutes les dix minutes pendant une heure avec un facteur déclenchant, souvent retrouvé, un voyage, un stress, un déménagement.

Les métroragies sont d'abondance variable, pas toujours mais c'est un facteur pronostique important. L'écoulement du liquide amniotique est inconstant. A l'interrogatoire, il faut préciser les antécédents gynéco-obstétricaux, le déroulement de la grossesse actuelle, les facteurs déclenchants, le niveau socio-économique, le mode de vie et les habitudes toxiques.

L'examen général, donc la prise de tension artérielle, de poids, oedème des membres inférieurs, température. L'examen obstétrical, la palpation abdominale à la recherche des contractions utérines, donc on pose la main au niveau du fond utérin et on a un fond qui est dur. Mesurer la hauteur utérine pour avoir une appréciation plus ou moins exacte de l'âge gestationnel.

Préciser la présentation. L'examen au spéculum peut mettre en évidence une vaginite infectieuse, qui peut être la cause, ou bien une cervicite, et un écoulement du liquide amniotique, des poids. Le toucher vaginal, c'est l'examen de référence.

Il montre des modifications cervicales, le col et les membranes, ramollis tendant à s'ouvrir, une modification précoce du segment inférieur, le type et le niveau de la présentation, la présentation qui appuie bien sur le col et qui entraîne une envie de pousser, et l'intégrité des membranes. Les examens paracliniques. Le premier examen paraclinique, c'est l'échographie.

Et là, on parle d'échographie endovaginale, donc c'est l'échographie du col, la mesure de la longueur cervicale et la morphologie de l'orifice interne et ou la protrusion des membranes. Plus le col est court, plus le risque d'accouchement prématuré est grand. Le seuil de risque se situe entre 20 à 30 mm de longueur du col.

En pratique, la valeur seuil est de 26 mm. C'est un outil qui est objectif d'évaluation de risque, qui n'est pas observateur dépendant. Il permet de mieux détecter les patientes les plus à risque d'accouchement prématuré, diminuer le risque d'hospitalisation inutile et précise les indications d'une corticothérapie ou bien de la tocolyse.

Sur l'image en haut à gauche, on a une image d'un col, de longueur du col normal. La deuxième image en haut et à droite, on a un col qui est raccourci avec un orifice interne qui est ouvert, entre-ouvert et une protrusion des membranes amniotiques. Également, la même chose sur l'image en bas, donc un col qui est très raccourci avec une protrusion évidente des membranes amniotiques à travers un orifice interne ouvert.

L'échographie obstétrique participe à la recherche de l'étiologie, grossesse multiple, malformations utérines ou bien fibromes, avoir une idée sur le fœtus, le bien-être fœtal et l'estimation du poids fœtal et les anomalies du liquide amniotique. Le deuxième examen paraclinique, c'est la tocographie et la cardiotocographie, pratiquée chez une patiente symptomatique pour apprécier la présence, l'intensité, le rythme des contractions utérines. Il permet d'évaluer l'efficacité de la tocolise et de surveiller la dynamique utérine.

Les marqueurs biochimiques et le premier marqueur, c'est la fibronectine encofœtale. Normalement, elle est absente dans les sécrétions vaginales. Produit par l'interface coriandrédissilu, le liquide amniotique est la matrice extracellulaire.

Sa libération se fait suite à la séparation des tucs fœtaux de l'utérus maternel lors de contractions utérines. En cas de contraction pathologique, cette fibronectine est détectée au niveau des sécrétions vaginales. Le prélèvement, il se fait à membrane intacte si la dilatation est inférieure à 3 cm et entre 24 et 34 semaines d'améliorer.

Le prélèvement par écovillonnage du col du sac vaginal est la valeur seule de détection et de 50 ng par millilitre. L'alpha-futoprotéine, retrouvé à des concentrations élevées lors d'une infection ovulaire. Les facteurs vaginaux de l'inflammation, les cytokines vaginales libérées suite à l'infection.

Des phosphatases alcalines surexprimées sous l'influence de ces cytokines. Ces phosphatases alcalines entraînent une activation de la production de médiateurs de l'inflammation, des activateurs de la contraction utérine et de la maturation cervicale. Les autres facteurs, en cours d'études et de validation, sont les cytokines, les corticotropines liées aux hormones et le striol salivaire.

Au total, devant des symptômes, le toucher vaginal demeure l'examen de référence. L'échographie examine de deuxième ligne permettant de chiffrer les modifications cervicales dans la longueur du col avec un seuil de 26 mm. La fibronectine peut être utilisée pour une longueur cervicale entre 15 et 26 mm, car s'il est négatif on peut éviter l'hospitalisation.

Le diagnostic de gravité, il tient compte de l'âge gestationnel, de l'importance des contractions utérines, la fréquence et l'intoxicité, des modifications locales du col et du segment inférieur, des facteurs associés, métrorragie, rupture des membranes, des facteurs étiologiques, l'infection, hydramnose, placenta prévia, grossesse générale. Chez le fœtus, il y a l'enregistrement cardiotopographique et l'échographie qui permet de préciser la biométrie fœtale, est-ce que la grossesse est monofœtale ou mutible, la présentation, la maturité, la vitalité, l'absence de malformations, la topographie et le grade du placenta et la quantité du liquide amniotique. Il y a plusieurs scores pronocytes mais j'ai choisi un score qui est plus facile, le score de Baumgarten.

Il tient compte des contractions utérines, l'état des membranes, la présence ou non des

métrorragies et la dilatation du col. Comme vous voyez sur le tableau, donc l'absence de contractions c'est 0, des contractions irrégulières c'est 1, 1, des régulières c'est 2, l'état des membranes sont intactes c'est 0, rupture haute c'est 2 et rupture basse c'est 4, les métrorragies donc absente c'est 0, minime c'est 1 et massive c'est 3 et la dilatation donc de 0 inconformé jusqu'à une dilatation supérieure à 4 cm c'est 4. Ce score il tient compte de la gestationnelle, des résultats, de l'échographie et du score plutôt le pronostic, il tient compte des termes gestationnels, des résultats, de l'échographie et du score. Un score à 3 c'est une menace légère, entre 4 et 6 c'est une menace modérée et supérieur égal à 7 c'est une menace sévère.

Le diagnostic étiologique selon l'urgence de la situation il peut ou non précéder la tocolise, on demande une numération formule sanguine, des bandettes urinaires avec la recherche d'une protéinurie du nitrite, leucocyturie, un ECBU, un prélèvement bactériologique vaginal, des hémocultures si la température est supérieure à 38, la recherche d'une rupture des membranes. Le diagnostic différentiel c'est avec l'hématome rétroplacentaire donc qui est posé chez une patiente en principe prééclampsique qui présente des métrorragies minimales noires avec une hypertonie utérine donc ce sont des contractures utérines sans relâchement entre les contractions. Les douleurs d'origine digestive, appendicite, colocolite, d'origine urinaire, pyélonéphrite, colopnephritique.

Le traitement, le but du traitement c'est stopper la menace d'accouchement prématuré pour éviter l'évolution vers l'accouchement prématuré, prévenir les complications de la prématurité, adapter des mesures d'hygiène, inhibition pharmacologique de la contraction utérine par la tocolise, identification et traitement adapté de l'étiologie. Les principes, donc on a un traitement préventif et un traitement curatif. Le traitement curatif, il y a deux volets, le traitement symptomatique et le traitement étiologique.

Donc les quatre volets du traitement c'est le repos, l'hospitalisation, la léthocolite, la prévention de la maladie des membranes et alignes par la corticothérapie et des mesures adjuvantes, donc un traitement étiologique, oncolithérapie et tout ça. Le traitement préventif, le meilleur traitement de la menace d'accouchement prématuré est préventif. Il repose sur l'information de la patiente au risque d'accouchement prématuré, la recherche des facteurs de risque, des mesures à prendre, amélioration des conditions de travail, limitation des longs trajets, respect des congés prénatales et conseils de repos, interdiction des sports, évitement du tabac, traitement précoce des infections urinaires et cervico-vaginales, et en cas de béance cervico-isthmique confirmée, il faut faire un cerclage, comme j'ai dit, à 15 semaines d'améliorer.

Pour le traitement curatif, il repose sur deux volets, un traitement symptomatique et un traitement étiologique. Le traitement symptomatique c'est le repos et l'hospitalisation, cessation d'activité et non un repos strict au lit, donc un risque thrombotique, pas de preuve d'efficacité d'arrêt des rapports sexuels, hospitalisation ou le maintien à domicile, tenir compte des contractions utérines, des résultats de touches vaginales, état des membranes, échographie, fibromyomètre et

le score. La tocolyse, il y a plusieurs molécules tocolithiques et on commence par le chef de file, c'est les bêta-2-mimétiques.

Le mécanisme d'action, ce sont des dérivés de catecholamine qui donnent une stimulation des récepteurs bêta-adrénergiques, inhibe l'interaction axonin et donc un relâchement de la fibre musculaire. C'est un traitement tocolithique de référence. Le mode d'administration, soit par voie intraveineuse, donc des ampoules de 0,5 mg de salbutamol, 5 ampoules dans 500 cc de Ringer à débit de 25 ml par heure.

Elle est efficace avec une demi-litre de 6 heures. Par voie orale, le salbutamol, ce sont des comprimés de 2 mg, plusieurs prises, en principe c'est une prise, toutes les 4 à 6 heures par jour. Et par voie rectale, donc la même chose que la voie orale, donc un suppos toutes les 4 à 6 heures et ce sont des suppos de 1 mg.

La conduite du traitement, un traitement d'attaque, par voie intraveineuse, au plus de 48 heures. Un traitement d'entretien, par voie orale et ou rectale, jusqu'à 37 semaines d'améliorer. Le relais intraveineuse per os sera fait 30 minutes avant l'arrêt de la perfusion.

La surveillance du traitement, des contractions utérines, du coup, la tension artérielle, la diurèse et les signes fonctionnels. Les effets secondaires sont des palpitations, tachycardie, tremblements, oppressions thoraciques, OAP, nausées, vomissements, vertiges, hyperglycémie, hypocalcémie. La tachycardie et l'hypoglycémie neonatale.

Les contreindications, c'est la cardiopathie décompensée, une coronaropathie, une myocardiopathie, HTA sévère, diabète, hyperthyroïde. Les inhibiteurs classiques, les mécanismes d'action, c'est la fermeture des canaux calciques qui empêchent l'entrée des ions calcium en intracellulaire et favorise le flux extracellulaire du calcium, ce qui entraîne une diminution du calcium intracellulaire et donc un relâchement de la fibre musculaire. Les molécules, c'est l'amlodipine, donc l'adalate, sont des comprimés de 2 mg ou bien des comprimés épais de 20 mg ou bien la nifédipine, qui sont des comprimés de 30 mg.

La dose d'attaque, donc c'est un comprimé de 10 mg, soit toutes les 15 minutes ou bien toutes les 20 minutes. Maximum, c'est 4 comprimés par heure. Le relais se fait par l'adalate RETA-FP, c'est 3 comprimés par jour pendant 48 heures.

(24:10 - 29:48)

La nifédipine ou bien le diltiazem, donc la posologie, c'est 3 à 4 comprimés par jour, 2,5 ampoules dans 250 cc de serum glucosée, à raison de 2 mg heure, on peut aller jusqu'à 4 mg heure. L'efficacité est largement démontrée, mais il n'y a pas d'AMM dans l'amlodipine d'accouchement prématuré. Elle a moins d'effets secondaires, donc tachycardie, HTA, bouffée de chaleur et céphalée.

Meilleure tolérance, c'est une bonne alternative au bêta 2 mimétique. Le deuxième, le troisième produit tocolithique, ce sont les antagonistes de l'ocytocine, la dose IVAN ou bien le tractocyle comme nom commercial. C'est un antagoniste sélectif des récepteurs à l'ocytocine vasopressine.

Il entraîne une diminution du calcium intracellulaire. Mode d'administration, c'est 6,75 mg en intraveineuse directe en 8 minutes, une consolidation par la suite de 300 microgrammes par minute, donc du serum glucosée pendant 3 heures, et puis on passe à 100 microgrammes par minute pendant 15 à 45 heures. Aussi efficace que le bêta 2 mimétique, en cas de récurrence, un autre cycle peut être prescrit, mais la seule limite de ce produit, c'est le coût, qui est très cher, donc c'est environ 500 euros par cure.

Il est recommandé de l'utiliser en cas de contre-indication au bêta 2 mimétique ou bien à l'enfer d'épines et en cas de menace trop sévère. Les autres tocolithiques, les ANS, exemple l'endométhasine, 100 à 150 mg, elle évalue la synthèse de prostaglandine, mais elle doit être utilisée à courte durée, moins de 72 heures et avant 34 semaines d'améliorer parce qu'il y a risque de fermeture du canal artériel. La progestérone, efficacité non prouvée en phase aiguë, les antispasmodiques, efficacité également non prouvée, le sulfate de magnésium, elle est efficace, son efficacité n'est pas supérieure au bêta 2 mimétique, mais l'avantage, c'est qu'il permet de prévenir les troubles neurologiques chez les nouveaux.

Au total, l'anophyllipine présente l'avantage d'être facilement accessible, administrée par voie orale, moins onéreuse que les bêta 2 mimétiques et les antagonistes des récepteurs à l'ocytocine. Ces avantages sont particulièrement importants dans les milieux défavorisés. La prévention de la maladie des membranes myélines par des corticoïdes, il se fait entre 24 et 34 semaines d'améliorer.

Deux produits peuvent être utilisés, la bêta-métazone ou bien la dexamétazone. La bêta-métazone, c'est une injection de 12 mg par voie intramusculaire qu'on répète 24 heures plus tard. Ou bien la dexamétazone, ce sont 4 doses de 5 mg administrées à 12 heures d'intervalle.

Il n'y a pas de contre-indication absolue. Une cure à répéter éventuellement si la situation clinique redevient instable, après un délai de 10 à 14 jours en particulier avant, 4 à 30 semaines d'améliorer. La réduction considérable de la mortalité natale, du risque de détresse respiratoire, des hémorragies intraventriculaires et des entérocolites nécrosantes.

Quatrième traitement symptomatique, c'est le transfert d'un utéros. Le principe, c'est de transférer la malade, le bébé au ventre de son, ou bien dans l'utérus de sa maman, vers un centre de référence néonatale. Bien sûr, si le trajet est lent, supérieur à une heure, il faut donner un comprimé d'adalate retard, même règle de référence.

Après avoir vu le traitement symptomatique, on arrive au traitement étiologique. La place du cerclage tardif, un rôle préventif strict, aucun rôle devant la menace aiguë par rapport au geste

risqué, c'est un geste qui n'est pas facile, avec un risque très important d'embrocher les membranes amniotiques et là on va rajouter au risque de prématurité le risque d'infection. Son efficacité n'est pas prouvée.

L'antibuthérapie, elle est indiquée en cas de rupture des membranes, pas d'efficacité de montrer si les membranes sont intactes, s'il y a une infection urinaire il faut traiter en fonction des résultats de l'ECBE et de l'antibiogramme. Si infection cervico-vaginale, il y a risque de courir amniotite infraclinique dans 60 à 75 % des cas, donc on traite par une amoxicilline ou bien de l'érythromycine. C'est 2 g par jour.

(29:51 - 32:01)

Les indications, il tient compte de l'âge gestationnel, des résultats de l'échographie et du score. Si le score est égal à 3, c'est une menace légère, donc il faut recommander le repos avec un traitement ambulatoire. Si la menace est modérée, donc un score de 4 à 6, il faut faire une tocovise.

Si elle est supérieure ou égale à 7, menace sévère, il faut préparer l'accouchement et le transfert. Donc c'est un tableau récapitulatif devant une conduite à l'accouchement prématuré. La surveillance, l'évolution peut être défavorable vers l'accouchement prématuré si le score de tocovise est élevé, si l'échographie du col et la longueur cervicale inférieure à 15 mm, si la recherche de fibronectine est positive et l'efficacité de la tocovise et l'étiologie est non traitée, ou bien s'il y a des signes d'alarme qui sont présents, par exemple si sévère, décollement placentaire, infection intra-utérine.

La prise en charge néonatale avant 34 semaines d'améliorer, risque de prématurité avec une immaturité pulmonaire, digestive et pathique immunologique. Le risque de mortalité et de morbidité est très important et le risque de garder des séquelles neuropsychiques chez cet enfant. En conclusion, intérêt du diagnostic, faire un diagnostic précis permet de prévenir l'évolution vers l'accouchement prématuré.

Il faut traiter bien sûr un traitement adapté, un traitement symptomatique dont le principe c'est d'arrêter les contractions et prévenir la maladie des membranes myéline et un traitement étiologique et bien sûr il faut avoir une prise en charge néonatale. Je vous remercie.